

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE	Notfallstandard Sturz	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Definition:

Ein Sturz ist jedes plötzliche unbeabsichtigte und unkontrollierte Herunterfallen oder Gleiten des Körpers aus dem Liegen, Sitzen oder Stehen auf eine tiefere Ebene.

1. Ziel:

- Eine etwaige Gesundheitsschädigung des Bewohners soll korrekt erkannt werden, damit eine angemessene medizinische Versorgung zeitnah eingeleitet werden kann
- Der Bewohner soll durch den Sturz nicht das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten verlieren
- Die Einrichtung muss vor unangemessenen Schadensersatzansprüchen geschützt werden
- Die Mitarbeiter der Pflege sind in der Lage unverzüglich, gezielt, sicher und umsichtig zu handeln

2. Anwendungsbereich:

Allgemeines:

- Wir achten auf eine fundierte Sturzprophylaxe für alle Bewohner. Der Expertenstandard „Sturzprophylaxe“ wird sorgfältig umgesetzt
- Die richtigen Maßnahmen nach einem Sturz werden regelmäßig im Rahmen der Erste-Hilfe-Schulungen thematisiert
- Alle Pflegekräfte werden instruiert, bei telefonischen oder schriftlichen Anfragen der Krankenkasse, hinsichtlich eines Sturzes, auf die Pflegedienstleitung zu verweisen und selbst keine inhaltlichen Angaben zu machen

3. Durchführung und Zuständigkeiten:

Erste Maßnahmen nach einem Sturz, bzw. Auffinden des Bewohners:

- Der Bewohner wird mit seinem Namen angesprochen und beruhigt
- *Hinweis zur Bewusstseinsprüfung:*
 - Stellen einfacher ragen, die einer ggf. vorhandenen dementiellen Erkrankung angemessen sind, etwa nach dem eigenen Vornamen oder dem Vornamen der Mutter/des Vaters.
 - Genaue Beobachtung des Bewohners, während er antwortet
- Holen von Hilfe von Kollegen über das Diensthandy oder lautes Rufen
- Vitalzeichenkontrolle (Blutdruck, Puls, Blutzucker)
 - Diese dienen bei späteren Kontrollen als Vergleichswert
- Kontrolle, ob eine Gehirnerschütterung vorliegt. Anzeichen dafür sind:
 - Übelkeit oder Erbrechen
 - Erinnerungslücken, insbesondere zum Sturzhergang
 - Änderung der Pupillenweite

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	1	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE SEIT 1988. BESTE PFLEGE.	Notfallstandard Sturz	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Kopfschmerzen
- Schwindel

- Hat der Bewohner Schmerzen?
 - Damit rechnen, dass Schmerzen durch den Schock unterdrückt werden können
- Prüfen, ob äußerliche Verletzungen erkennbar sind
- Inspizieren von Bereichen, die durch Kleidung verdeckt sind. Insbesondere wird die Hose geöffnet, um die Knie, Unter- und Oberschenkel in Augenschein zu nehmen.
 - Bei Schmerzfremheit:
 - Alle vier Extremitäten werden vorsichtig durchbewegt, um Frakturen ausschließen zu können (ACHTUNG: Auf Schmerzzeichen beim Bewohner achten!)
 - Je nach Mobilität des Bewohners, diesen auffordern, sich auf den Bauch zu drehen
 - Danach hilft die Pflegekraft dem Bewohner dabei, in den „Vierfüßler Stand“ zu kommen
 - Der Bewohner soll zunächst ein Bein aufstellen und sich dann, ggf. mit Unterstützung der Pflegekraft aufrichten
- Im Abstand von 1,2,6,12,24 Stunden, bei Bedarf auch öfter, wird der Gesundheitszustand des Bewohners erfasst. Kriterien hierfür sind:
 - Bewusstseinszustand
 - Vitalwerte (Blutdruck, Puls, Blutzucker, Körpertemperatur)
 - Veränderung der Pupillengröße
 - Beweglichkeit
 - Schmerzäußerungen des Bewohners
 - Schwellung/ Hämatome
- In den folgenden Tagen wird der Bewohner beobachtet (Veränderungen im Gang, Schonhaltung)
 - Wenn der Bewohner über Schmerzen klagt, sich nicht bewegen kann, in abnormaler Lage am Boden liegt oder unfreiwillig Harn verliert, wird von einer Fraktur ausgegangen
- Bei Gefahr von Kontamination mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten oder Körperausscheidungen sind Handschuhe zu tragen
- Notarzt informieren (**Rufnummer: 0-112**)
- Es wird mit der Rettungsleitstelle vereinbart, dass ein Mitarbeiter des Hauses die Rettungskräfte vom Fahrstuhl im Hof bis zum Zielpunkt begleitet
- Nach Eintreffen des Notarztes nach ärztlicher Anordnung handeln
- Die Krankenhauseinweisung wird gemäß Verfahrensanweisung vorbereitet
- Bewohner auf dem Boden liegen lassen und nicht bewegen
- Bewohner mit einer Decke zudecken, so dass er nicht auskühlt
- Den Bewohner nicht allein lassen, bis der Notarzt eintrifft
- Den Bewohner ggf. beruhigen
- Falls sich der Bewohner übergibt, werden die Atemwege freigehalten

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	2	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIRTSCHAFTS-UNIVERSITÄT WIEN	Notfallstandard Sturz	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Maßnahmen bei Verletzungen:

- Bagatelverletzungen, also etwa Abschürfungen, werden versorgt
- Offene Wunden werden steril bedeckt und Blutungen ggf. mittels eines Druckverbandes gestoppt
- Bewohner mit Nasenbluten werden aufgefordert, den Kopf nach vorne zu beugen und das Blut in einer Nierenschale zu sammeln. Die Pflegekraft legt dem Bewohner kalte Kompressen in den Nacken
- Besondere Vorsicht ist geboten bei Bewohnern, die Antikoagulanzen (Gerinnungshemmer) einnehmen

Informationsbeschaffung für die spätere Dokumentation:

- Wenn möglich, wird der Bewohner über den Sturzhergang befragt
- Es wird geprüft, ob jemand den Sturz beobachtet hat
- Der Sturz Ort wird dahingehend in Augenschein genommen, ob Auslöser des Sturzes zu erkennen sind. Diese werden sofort beseitigt.

Nachbereitung:

- Information an Angehörige/Betreuer
- Information an die Pflegedienstleitung/stellvertretende PDL
Wenn die Notsituation am Wochenende/Feiertag eintritt, wird die Information am folgenden Werktag weitergegeben
- Information an den Hausarzt
- Information an die nachfolgenden Schichten und Übergabe der noch ausstehenden Kontrollen der Pupillen und Vitalzeichen
- Überprüfen, ob weitere Hilfsmittel zur Sturzvermeidung notwendig sind und dieses mit dem Bewohner/Betreuer und Angehörigen besprechen
- Anschaffung der Hilfsmittel in die Wege leiten (Kontakt mit Ärzten, Sanitätshäusern und Krankenkassen aufnehmen)
- Überprüfen, ob eine Fixierung (Bettseitenteile, Bauchgurt oder Stecktisch) sinnvoll ist und dies mit der Pflegedienstleitung, Betreuer und ggf. Bewohner besprechen
- Fallbesprechung im Team

Dokumentation:

Dokumentiert wird unter:

- Berichtesblatt
- Ärztliche Kommunikation
- Vitalwerte
- Sturzprotokoll
- Neuerhebung des Assessments Sturzrisikoerhebung (DNQP)
- Ggf. Änderungen Pflegeplanung/Maßnahmenplan

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	3	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE SEIT 1978	Notfallstandard Sturz	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Es darf kein relevanter Faktor ausgelassen werden. Aus dem Bericht muss folgendes klar hervorgehen:
 - Letzter Bewohnerkontakt
 - Kleidung und Schuhwerk des Bewohners während des Sturzhergangs
 - Wann und wo das Ereignis stattfand
 - Welche Pflegekraft als erstes vor Ort war
 - In welchem Zustand und in welcher Position der Bewohner vorgefunden wurde
 - Ob es Zeugen gab
 - Ob der Bewohner Angaben zum Sturzhergang machen konnte
 - Ob er sich verletzt hat
 - Welche Maßnahmen getroffen wurden
 - Ob es vor Ort offensichtliche Auslöser des Sturzes gab
 - Alle durchgeführten Kontrollmaßnahmen, die noch nachträglich durchgeführt wurden (Vitalzeichen, Pupillenkontrolle etc.)
- Beratung von Bewohner, Angehörigen und Betreuer dokumentieren

Durchführungsverantwortlichkeit:

- Alle Pflegekräfte

Prozessverantwortlichkeit:

- Pflegedienstleitung, QMB, stellvertretende PDL, Wohnbereichsleitung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	4	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.